



بناء الجلسات العلاجية ومراحل العلاج
التطبيق العملي

دليل جلسات العلاج المعرفي السلوكي CBT

Abdulaziz Aljemaiah

Senior Clinical Psychologist

بناء الجلسات العلاجية ومراحل العلاج

التطبيق العملي للعلاج المعرفي

- عرض لشكل بناء الجلسة وكيف تختلف وفقا للمرحلة العلاجية للحالة المحددة.
- من اهم الملامح المميزة للعلاج المعرفي بناء المقابلة الذي يتضمن وضع جدول أعمال للجلسة Agenda والحصول على عائد ومهام الواجب المنزلي Homework assignment.
- ومن المهم أيضا أن يكون المنطق وراء التدخلات العلاجية واضحا لكل من المعالج والمريض، هذه الطريقة تيسر ارتباط المريض بالعملية العلاجية .
- شكل المقابلة بقدر كبير من العلاج السلوكي بما تتضمنه من وضع أهداف، وتحليل المشكلات الى عناصر نوعية، وتحديد الإجراءات وقياس مدى التقدم، التكاتف في تحديد مهام الواجب المنزلي .
- أما طريقة الاستفهام فقد اشتقت أساسا من طريقة السوابق الترابطية Associative anamnesis كما استخدمها "فليكس" و"دوتش" Felix & Deutsch "وكارل روجرز" Carl Rogers في العلاج غير الموجهة Non-directive therapy وطريقة الاستفسار السقراطي كما استخدمها "البرت أليس" A.Ellis في العلاج العقلاني الانفعالي .
- يمكن تقسيم فترات العلاج المعرفي إلى ثلاث مراحل أساسية هي:

1. مرحلة بداية العلاج Beginning of the treatment

2. المرحلة الوسطى The Middle phase

3. المرحلة النهائية The final phase

مرحلة بداية العلاج

- بداية العلاج تتجمع أهداف عديدة على المعالج أن يعمل على تحقيقها في البداية مع المريض.
- هذه الأهداف يمكن وضعها في ثلاث فئات هي:

- التقييم Assessment
- تطبيع المريض داخل النموذج المعرفي
- التعامل مع أعراض خطيرة لدى المريض كالانتحار والتشاؤم والامتناع عن الطعام
- غالبا يحدث تحقيق لتلك الأهداف في الجلسة الأولى أو الثانية مع استمرار متابعة التحسن في الجوانب الأخرى في تلك الجلسة والجلسات التالية .

• يتعلق بهدف التقييم فانه يحدث في جزأين:

- الأول هو عملية التشخيص والتقييم النفسي ويتم في صورة مقابلة يقوم المعالج النفسي أو القائم بالتشخيص اثناءها بعمل التشخيص الدقيق وقياس الجوانب المعرفية والشخصية والاجتماعية والتاريخ الشخصي للحالة
- وفي هذه المقابلة بالإضافة الى تشخيص الاضطراب باستخدام دليل تشخيصي أو أداة مناسبة يتم قياس جوانب ترتبط بالاضطراب

- مثل قياس شدة الاكتئاب باستخدام بطاريه بيك للاكتئاب الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية
- شدة الاضطراب يقوم الباحثون عادة بقياس بعض المظاهر المعرفية المرتبطة بالاكتئاب مثال ذلك :
- قياس فقدان الامل

• الاتجاهات المضطربة Dysfunctional attitudes

• أساليب العزو Attributional style

- والأساليب المعرفية
- ومقاييس تقدير المخططات الذاتية والأفكار الذاتية
- ويستخدم مقاييس عديدة لقياس تلك المتغيرات لمتابعه التغيير أثناء وبعد العلاج المعرفي
- وعادة يتم تقييم تلك الجوانب ضمن مقابلة التشخيص قبل بدء العلاج

الجلسة العلاجية الأولى

- عملية التقييم والتشخيص
- تستغرق حوالي 90 دقيقة
- ويكون الهدف الأساسي منها الاهتمام بتشجيع الامل، وذلك ببدء العلاج فوراً
- وأيضاً من أهدافها إمداد المريض بمعلومات حول النموذج المعرفي، ومنطق العلاج
- بناء الجلسة العلاجية الأولى مختلف قليلاً عن الجلسات التالية حيث تكون مرحلة استكشافية للمعالج في التعرف على مشكلات المريض الحالية وعمل صياغة للحالة في ضوء المفاهيم المعرفية.

● المكونات الأساسية في الجلسة الأولى هي:

- تقدير الصعوبات الراهنة
- تحديد الهدف العام
- وتقديم منطق العلاج
- ثم بدء العلاج.

● أولاً / التعرف على مشكلات المريض:

- أثناء ذلك يقوم المعالج بجمع معلومات كافية حول بداية الاضطراب، تطوره، ومحاولات العلاج السابقة .
- ويتم بالتزامن مع ذلك محاولة ترسيخ الخصائص الهامة للعلاقة العلاجية أثناء الجلسة بما فيها الاستماع المنصت، الفهم المتعاطف، بناء الثقة، وإظهار الاهتمام.....لخ
- التفاصيل التي يقدمها المريض في هذه المرحلة تكون مهمه في تكوين صياغة مبدأيه للحالة توجه في ضوء النموذج المعرفي
- يتم وضع قائمه المشكلات الحالية للمريض، سواء كانت مشكلات مهنية، مشكلات اجتماعية أو مشكلات شخصية
- ويقوم المعالج من وقت لآخر بعمل تلخيصاً لما قاله المريض

- ويطلب من المريض عائدا للتأكد من أن ما قاله المعالج يعكس بدقة ما كان يقصد المريض قوله
 - قائمة للمشكلات تعد خطوة هامة جدا في هذه المرحلة
 - حيث يأتي مريض الاكتئاب عادة بقائمة لا تنتهي من الشكاوى النوعية منها والعامّة
 - مما يساعد في تحديد مجالات أساسية للمشكلات هو أن يقوم المعالج بتدوينها ثم ربطها بالأعراض والمشكلات النوعية المرتبطة بكل مجال منها
- من المهم أيضا في تلك المرحلة استكشاف الأعراض المرتبطة بفقدان الأمل، والانتحار، فإن وجدوا فإنها تمثل نقطة البداية للتدخل العلاجي

ثانيا / تحديد الأهداف

- المقابلة الأولى أيضا يتم تحديد الأهداف المرتبطة بكل مشكلة أو الهدف العام من العلاج
- فبعد تحديد المشكلات الحالية للمريض، والتأكد من أن المريض ليس معرضا لخطر محاولة الانتحار يتم مساعدة المريض في ترجمة المشكلات المحددة في صورة أهداف للعلاج
- يساعد في كتابة أهداف محددة أن نوجه للمريض سؤال مثل:
- " كيف تود أن تختلف الأشياء في هذا المجال؟"
- أو " أفترض أن العلاج بدأ تأثيره فكيف ستختلف الأشياء بالنسبة لهذه المشكلة "
- قد تتغير عبر مسار العلاج، حيث تبدو في البداية بعض الأهداف غائمة
- أو أن عدم القدرة على اتخاذ قرار تؤثر في رؤيته للأهداف حاليا، فإن تعديلا مستمرا يحدث لقائمة الأهداف
- وقد تظهر أهداف جديدة في مرحلة متقدمة من العلاج
- أن الجهد المشترك بين المعالج والمريض في تحديد الأهداف يساعد في
- تصحيح أي توقعات غير حقيقيه عن العلاج
- كما أن يقدم معيار ثابت نسبيا لمراقبة التقدم في العلاج
- كما أنه يشجع المريض في تركيز انتباهه على المستقبل وليس على الماضي

ثالثاً / تقديم منطق العلاج:

- بداية العلاج المعرفي أن يكون لدى المريض والمعالج فهما عاما للنموذج المستخدم في العلاج
- يفيد في ذلك الجانب أن تستكشف أولاً معلومات المريض عن العلاج المعرفي
- إعطاء مثال للأفكار الذاتية وكيف يمكنه تحديدها أو الإمساك بها والتعرف عليها
- ويتضمن في هذا الهدف أيضاً أن يقدم للمريض معلومات حول الجوانب العلمية في العلاج مثل عدد الجلسات، ومدة كل جلسة ومعدلاتها
- كذلك ما يتبع عادة من استخدام للواجبات المنزلية والعمل بشكل متكاتف على حل المشكلات

رابعاً / بدء العلاج:

- العلاج العمل الفعلي مع المشكلات النوعية، والاهداف العلاجية المرتبطة بكل منها بهدف إحراز تقدم في تخفيف الاعراض الاكتئابية 0 ويدخل فيها:
- تطبيق الأساليب العلاجية في حل المشكلات
- اقتراح مهام كواجبات منزلية في الوقت بين الجلسات
- ترسيخ فكرة العلاقة التكاتفية في فحص المشكلات
- تحديد الأفكار الذاتية السلبية المرتبطة بالمواقف المحددة وكيفية التعرف عليها ليتم فحص وتحديد مدى دقتها
- المشكلات الأولية التي يتم التركيز عليها في بداية العلاج هي مشكلة التشاؤم Pessimism، وأعراض فقدان الأمل وذلك لارتباطها بالانتحار

- التدخلات العلاجية تتضمن العمل من خلال المهام التي لم يكن المريض قادر على فعلها، أو المهام التي يعتقد المريض أنه ليس لديه قدرة كافية للتغلب على الصعوبات المحيطة بها
- وفي البداية يستوضح المعالج ويقوم بتسجيل توقعات المريض عن أدائه للمهمة، ومن ثم توجيه المريض من خلال استباق العوائق التي قد تحدث أثناء إكمال المهمة ومناقشة كيفية التغلب على كل عائق
- المرحلة من بداية العلاج يتم ترسيخ التكاتف النشط في العلاقة العلاجية، وإعطاء الأمل ومحاولة تخفيف الأعراض الانفعالية
- ويتم إعطاء مهام لتتجز بين الجلسات
- ومهام الواجب المنزلي الملائمة لبداية العلاج يمكن أن تتضمن:
 - تسجيل الأنشطة اليومية
 - مراقبة الأفكار الذاتية
 - أو قراءة الملخصات التوضيحية حول العلاج المعرفي
 - أو الاستماع إلى شريط تسجيل للجلسة العلاجية والتعليق عليه في بداية الجلسة التالية

مثال عملي لقائمة المهام بين الجلسات:

- ولقد حددت "بيك" (1995) بالعمل المتبادل مع أحد مرضاها قائمة بمهام الواجب المنزلي تتضمن ست مهام كالآتي:
 - إعادة صياغة قائمة الأهداف العلاجية .
 - اسأل نفسي عندما تتغير حالتي المزاجية "ما الذي يدور بذهني الان؟" ثم أقوم بكتابة الأفكار والصور .
 - وأذكر نفسي بأن هذه الأفكار قد تكون صحيحة أو غير صحيحة
 - أذكر نفسي بأنني مكتئبة الان، ولست كسولة، وهذا هو السبب في أن الأشياء تبدو صعبة بالنسبة لي .
 - أفكر في البنود التي أريد أن أناقشها في جدول الجلسة القادمة (أي المواقف أو المشكلات)، وكيفية تسميتها
 - أقرأ الكتيب وملاحظات العلاج

○ أن أذهب للسباحة أو الجري ثلاث مرات خلال هذا الأسبوع

- وتذكر "بيك" أنه على المعالج أن يتأكد من أن المريض سينجح في تنفيذ الواجبات، إذا شعر أن المريض لن ينفذ أي جزء من الواجب فقد يقترح إلغائه من قائمة الواجب في الجلسة الحالية (Beck,1995,P.40)
- نهاية الجلسة تقدم ملخصا لما تم فيها
- وتختتم الجلسة عادة بعد التحديد المتكاتف للواجبات المنزلية
- ثم يطلب عائد من المريض حول الجلسة
- فإن ذلك يسمح للمريض أن يتحدث عن ردود أفعاله السلبية حول مهام الواجب المنزلي
- كما أن طلب عائد من المريض يعمل على تقوية العلاقة العلاجية وتقدم للمريض رسالة مؤداها "أن المعالج يهتم بما أعتقده حول العلاج"
- كما أنها فرصة ليعبر المريض عما قد يكون قد حدث من سوء فهم وبالتالي يكون على المعالج تصحيحه
- العائد يمكن أن يقدم في صورة مكتوبة أيضا ولقد اقترحت "بيك" 1995صيغة لتقديم عائد مكتوب كما ينصح في التالي:

تقرير العلاج (نهاية كل جلسة)

1. قمتم أنت والمعالج بتغطية اليوم ومن المهم أن تتذكره؟
2. إلى أي حد تشعر أنك يمكنك الثقة بالمعالج اليوم؟
3. هل ضايقتك شيء حول العلاج اليوم؟ في حالة نعم؟ فما هو؟
4. ما مقدار الواجب الذي جهزته لجلسة اليوم؟ ما هو الاحتمال بأن تقوم بعمل الواجب الجديد؟
5. ما الذي تريد أن تؤكد رغبتك في تغطيته في الجلسة القادمة؟

شكل (3-3)، تقرير العلاج . نقلا عن : (Beck , 1995 , P.42)

المرحلة الوسطى من العلاج

- الثانية وما بعدها لها نفس البناء حتى مرحلة انتهاء العلاج والبناء المعتاد للجلسات العلاجية التالية للجلسة الأولى تتضمن البنود التالية:
 1. وضع جدول عمل للجلسة
 2. البنود الأسبوعية
 3. الخطة الأساسية لليوم
 4. مهام الواجب المنزلي
 5. العائد

1 - وضع جدول أعمال للجلسة (أجندة):

- بمثابة تحديد هيكل بناء الجلسة العلاجية في العلاج المعرفي . وذلك يتضمن دائما وكنقطة بداية للجلسة وضع جدول عمل للجلسة العلاجية
- يتضمن جدول العمل مخطط لما سيتم إنجازه أثناء الجلسة

- يتم وضع بنود جدول أعمال الجلسة بشكل متكاتف بين المعالج والمريض
- فيبدأ المعالج بتوضيح ذلك للمريض ويقترح النقاط التي يراها مهمة في المرحلة العلاجية المعينة
- ثم يعرض على المريض أن يضيف أي بنود يود تضمينها في جدول أعمال الجلسة
- بند يقترحه المعالج في جدول الاعمال يحاول أن يذكر المنطق وراء تضمينه مع تقديم منطق لوضع جدول أعمال بصفة عامة 0 وهناك بنود في دفتر الاعمال تتكرر كل جلسة تقريبا مثل:
 - مراجعة الحالة المزاجية للفرد من طريق تقديرها بنسبة مئوية أو درجة موضوعية
 - مراجعة الواجب المنزلي
 - الاحداث ما بين الجلسات التي لها علاقة بالحالة الانفعالية .
 - تضمين ما يريد المريض تضمينه كموضوع للمناقشة داخل الجلسة، الموضوعات الكبرى التي يود مناقشتها في الجلسة المرتبطة بمشكلات محددة
 - تحديد مهام الواجب المنزلي لما بعد الجلسة
 - توضيح المهمة ومنطق كل منها
- عند وضع أكثر من موضوع للمناقشة فإن المعالج والمريض يقومان معا بعمل قائمة بالأولويات وفقا لأهمية وإلحاح كل موضوع بالنسبة للمريض
- يراعى عند وضع جدول أعمال الجلسة أن تكون عدد البنود ووقت العمل في كل بند يتناسب مع الوقت الكلي للجلسة الذي لا يزيد عن 60 دقيقة في جلسات العلاج المعرفي إلا ما ندر
- ويقترح البعض في هذا الشأن أن يتضمن جدول الاعمال فحص لمشكلة أو لموقف واجد من المشكلات الهدف والتركيز عليه بالإضافة إلى البنود المعتادة في جدول الاعمال حتى يتم تناوله بقدر كافي من الفحص والتفصيل .
- كما يراعى داخل الجلسة أن يتم توزيع الوقت بشكل يتناسب وحجم البند المحدد بحيث لا يتم إعطاء وقت كبير لتفصيله صغيرة في حين يكون نصيب موقف هام اخر أو مشكلة وقت قصير لا يتناسب مع أهميتها لدى المريض في الوقت المعين

2- البنود الأسبوعية:

- ويتضمن ذلك مراجعة الأحداث بشكل ملخص
- وظيفة ذلك توضيح كيف سارت الأمور منذ آخر جلسة، وبالتالي تسمح للمشكلات والاحداث المرتبطة بالعلاج أن تخرج للضوء
- وكذلك تلقي عائد عن الجلسة السابقة والاشياء البارزة فيها، وملاحظات المريض عنها إن وجدت، الجلسات تتضمن خبرات للتأمل والتعلم
- تتضمن البنود الأسبوعية أيضا مراجعة الواجب المنزلي، وطرح الصعوبات، ومناقشة طرق التغلب عليها في المرات القادمة .
- كما أنها توضح ما قد يكون حدث من سوء فهم للمهام
- وتقدم فرصة لتدعيم الشخص في جوانب الاستقلالية في الأداء، وخبرات التمكن المهمة في التخفيف الانفعالي للمرضى

3 – الخطة الأساسية لليوم:

- الجزء يستغرق الوقت الأكبر من الجلسة
- ويتم فيه مناقشة البنود التي اقترحت للتناول في الجلسة المعينة الخاصة بمشكلات ومواقف محددة، من خلال الاستراتيجيات السلوكية والمعرفية، مثل تعلم مناقشة الأفكار الذاتية السلبية
- في كثير من الأحوال يطلب المعالج من المريض أن يقوم بتحديد البنود التي يود البدء بالعمل فيها . أن فعل ذلك يقدم للمريض فرصة ليكون أكثر نشاطا وتوكيدا واتخاذ مزيد من المسؤولية
- المعالج بالاختيار حين يرى أن مناقشة بند معين من بنود الاجندة سيكون له تأثيرا كبير في التقدم العلاجي أثناء الجلسة 0 وقد يستهل ذلك بسؤال مثل: "هل تمنع من أن تقوم بمناقشة (س) في البداية؟"

- في هذه المرحلة من العلاج (المرحلة الوسطى) يتم تدريب المريض على مهارات المواجهة 0 فالبرغم من أن العمل مع مهارات المواجهة يكون بدأ بالفعل من المرحلة الأولى في العلاج إلا أن في المرحلة المتوسطة من العلاج يعمل المعالج والمريض معا على تقوية هذه المهارات
- المعالج بنسج الأهداف العلاجية من خيوط المناقشة مع المريض مهما كان موضوعها، فمثلا فالجلسة الثانية إذا كانت مشكلة " العمل " يتم مناقشتها فإن المعالج لا يقوم فقط بحل مشكلات المريض مثل مشكلة العمل لنصف الوقت، بل أيضا يقوم بالآتي:
- ربط الموضوع بالأهداف العلاجية التي وضعها المريض فيما قبل
- يقوم بتدعيم النموذج المعرفي في إطار فهم المريض للمواقف وتعامله معها
- الاستمرار في تعليم المريض تحديد الأفكار الذاتية السلبية
- العمل على تخفيف الاعراض من خلال مساعده المريض أن يستجيب للأفكار المقلقة
- أن يستمر في بناء علاقة مهنية قوية من خلال الفهم الدقيق للمريض ومشكلاته
- المرحلة من العلاج أيضا يتعلم المريض استخدام جدول تسجيل الأفكار الذاتية حيث يطلب منه المعالج أن يراقب حالاته المزاجية
- بعض المرضى يكون من الصعب عليهم في البداية التمييز بين الأفكار والمشاعر
- وهنا يكون دور المعالج في مساعده المريض في تحديد الأفكار وتمييزها عن المشاعر والانفعالات
- ويتم ذلك في إطار تأكيد المعالج أن مهاره تحديد الأفكار الذاتية والامساك بها ومناقشتها مهاره مثل أي مهاره تحتاج إلى وقت وتكرار لكي نصل فيها إلى مستوى معقول من الاتقان
- يقوم المعالج بمساعدة المريض في تحديد وتحسين الاستجابة للأفكار الذاتية، عن طريق استخدام الأساليب التي سبق وتعرفنا عليها
- في المرحلة الوسطى من العلاج يكون هناك بعض العمل أيضا على الافتراضات الضمنية والمخططات الأساسية
- يتم تحديد الافتراضات الضمنية اللاكيفية ومناقشة الارتقاء التاريخي لها
- هذا يساعد المريض في فهم الأنماط التي تم تحديدها

4/ مهام الواجب المنزلي :

- بنود العمل الأساسية في الجلسة وإعطاء تلخيص دوري لما يقال من قبل المريض، يقوم المعالج والمريض بتحديد مهام الواجب المنزلي لما بين الجلسات . وتكون مهام الواجب المنزلي أو مهام مساعده الذات التي تنفذ فيما بين الجلسات أكثر إفادة إذا توفر لها ما يلي:
- تتبع منطقي لما كان يحدث داخل الجلسة
- أن يتم تحديدها بوضوح وعيانيه بحيث يسهل التعرف على النجاح فيها (مثل أن يقضي خمس دقائق يقطع أشياء بالسكينة كل يوم " وليس " أن يصبح شخص أفضل في الأسبوع القادم)
- أن يكون هناك هدف واضح ومفهوم ومقبول لدى كل من المعالج والمريض مثال ذلك "لكي نختبر الفكرة القائلة بأنك لا تستطيع عمل أي شيء"
- أن يتم أعداد الموقف بحيث لا يكون هنالك شيء مفقود، بحيث يمكن تعلم شيئاً مفيداً منه، ونحدد ما إذا كانت النتيجة المرغوبة حدثت أم لا
- فرص الفهم الخاطئ والنسيان، من المفيد أن يقوم كل من المعالج والمريض بتدوين المهمة، والمنطق وراءها
- من المفيد أيضاً الاحتفاظ بتسجيل مكتوب لما تم عمله وماذا كانت النتيجة0 ويساعد في عمل ذلك بشكل منظم استخدام صيغ التسجيل المعياري مثل استخدام جدول تسجيل الأنشطة الأسبوعية و جدول تسجيل الأفكار المضطربة
- من الضروري عند تحديد مهام الواجب المنزلي أن نختار المهام التي يثق المعالج أن المريض يستطيع القيام بها لان الفشل في هذه المهام يؤثر في دافعية المريض، وفقدان الامل 0 بالإضافة إلى التحديد العياني للمهام، وكيفية تنفيذها، يكون من المهم استباق الصعوبات المتوقعة عند تنفيذها ويتم مناقشتها مع المريض مع اقتراح طرق للتغلب عليها
- في حالة أن يعود المريض للجلسة التالية بدون عمل مهام الواجب المنزلي فإن يجب مناقشة ذلك للتعرف على الأسباب التي قد تتضمن أفكار ذاتية سلبية حول المهمة أو جدواها 0 وفي هذه الحالة يتم مناقشة تلك الأفكار مع المريض أثناء الجلسة.

● 5/ العائد: feedback

- الأخيرة للمعالج في كل جلسة هي الحصول على عائد عن ردود أفعال المريض عن الجلسة، كأن يذكر ملخصاً للأشياء البارزة في الجلسة أو ما تعلمه أثناء الجلسة
- والعائد يساعد في اكتشاف مشاعر المريض حيال الجلسة، وخصوصاً إذا ما كان قد أزعجه شيئاً ما.
- ويجب أن يوضح المعالج للمريض أن هناك ترحيب بالعائد الأمين دائماً حتى وإن كان سلبيًا لأن ذلك يساعد على توضيح أخطاء الفهم، والتصرف وفقاً لحاجات المريض

● مرحلة إنهاء العلاج:

- العلاج المعرفي هو تيسير الشفاء من الاضطراب وتعليم المريض أن يكون هو المعالج لذاته، وليس الاعتماد على المعالج في حل كل المشكلات.
- في الحقيقة، إن المعالج الذي يرى نفسه مسئولاً عن مساعدة المريض في كل مشكلة يواجه خطر تدعيم الاعتمادية لدى المريض ويحرمه من فرصة اختبار مهاراته
- وقضية الانهاء يجب أن تناقش بشكل دوري أثناء العلاج .
- فمنذ البداية يؤكد المعالج للمريض أنه لن يبقى في العلاج بشكل غير محدد وأنه سوف يتعلم كيف يتعامل مع مشكلاته النفسية بنفسه 0 (Beck , et al . 1979, P.317) لأن العلاج المعرفي محدد بزمان فإن المشكلات المتعلقة بإنهاء العلاج ليست معقدة كما هو الحال في العلاجات التي تأخذ فترات أطول كالعلاج بالتحليل النفسي .
- طريقة الاغلاق تؤثر بشدة ، حيث أن كثير من فوائد العلاج المعرفي قد تفقد بسبب طريقة الانهاء غير الصحيحة. ولهذا فإنه من المهم جداً أن يتم التعامل مع عملية إتمام العلاج بشكل كفء
- على المعالج أن يعد المريض لمرحلة إنهاء العلاج والانتكاس منذ الجلسة الأولى 0 فمن المفيد تحديد توقعات المريض حول التقدم الذي يتوقعه، وكيفية ومدة العلاج ، وفترات التدهور والذبذبات في الحالة وهكذا 000 فإذا قام المعالج بإعداد المريض لتوقعات تذبذبات ، التدهور في الاعراض منذ البداية المبكرة ، فإنه يعزز من تفهم المريض وتحمله لها عندما تحدث

- وكذلك تأكيد المعالج أن الحياة بعد العلاج قد يحدث أثناءها تدهور للأعراض أو صعوبات من آن إلى آخر لكن المريض سيكون معد لذلك إعدادا جيدا بحيث يمكنه التعامل معها بمفرده .
- من الأشياء التي تقلل مشكلات الانهاء تأكيد الطبيعة التعليمية للعلاج المعرفي
- فالمعالج يمكنه تفسير حاجه المريض إلى اكتساب معرفة متخصصة وخبرة ومهارة التعامل مع أنواع معينه من المشكلات
- وأن العلاج هو فترة تدريب يمكن المريض خلالها أن يتعلم طرقا أكثر فعالية للتعامل مع هذه المشكلات
- والمريض ليس مطلوب منه أن يكتسب هذه المهارات بشكل كامل الاتقان، بل يتم التأكيد على النمو والارتقاء التدريجي للمهارات
- من الضروري أيضا التأكيد بأنه بعد انتهاء العلاج سيكون لدى المريض وقت كافي لتحسين هذه المهارات المعرفية والسلوكية
- أثناء المرحلة النهائية في العلاج يقوم كلا من المعالج والمريض معا بمراجعة المكاسب التي حصل عليها الفرد من خبرة العلاج باستباق المواقف الصعبة أو المشكلات التي قد تظهر في المستقبل وتتطلب استخدام مهارات المواجهة لدى المريض
- تعد تلك الخطوة خطوة مهمة حيث من الشائع ألا يدرك المريض أهمية المهارات التي تعلمها
- من المفيد أيضا عندما يقوم المعالج بتعليم المريض بعض الأدوات والأساليب، أن يؤكد المعالج في وقتها أن هذه المهارات بمثابة مساعدات مدى الحياة . فالمريض يمكن أن يستخدمها الآن مع عدد من المواقف وفي المستقبل
- من المفيد تذكير المريض بأهم الاستراتيجيات التي تم تعلمها اثناء العلاج مثل:
- من الأساليب والأدوات المعروفة التي يمكن أن تستخدم أثناء وبعد العلاج هي:
- تفتيت المشكلات الكبيرة الى مكونات أصغر يمكن التعامل معها
- توليد استجابات بديلة للتعامل مع المشكلات
- تحديد الأفكار والمعتقدات الذاتية واختبارها والاستجابة لها

- استخدام جدول تسجيل الأفكار والمضطربة
- ومراقبة وتسجيل الأنشطة
- القيام بتدريبات استرخاء
- استخدام أساليب التشنت وإعادة التركيز
- ابتكار وتجريب الطرق للتعامل مع مهام متدرجة الصعوبة
- كتابة قائمة بالعبارات الذاتية الإيجابية
- تحديد المميزات والعيوب للأفكار، والمعتقدات، والسلوكيات أو الاختيارات المحددة عند محاولة
- كثيرا من المرضى يعززون شفاءهم الى تغيرات في بيئاتهم، حتى إذا كان قد حدث هذا الشفاء نتيجة لمجهودهم الخاص .
- في هذه الحالة فإن على المعالج الاعتراف بتأثير تلك العوامل لكنه يسأل المريض عما حدث من تغيير في تفكير وسلوك المريض وقد يكون قد ساهم في أو ساعد على استمرار هذا التحسن .
- وعلى ذلك فإن على المعالج مساعدة المريض في اختبار وتطبيق المهارات التي تعلمها ،حتى يكون قادرا على استعارتها عند ظهور أي مشكلة في المستقبل
- مواجهه مخاوف الانهاء
- بعض المرضى تكون لديهم هموم يتم التعبير عنها بقولهم "لكننا لم نشفى تماما" وهذا موازيا للفكرة الذاتية القائلة " لن يمكنني التعامل مع المشكلات بدون مساعده المعالج".
- ويرى "بيك" أن هناك عدة طرق للتعامل مع هذه الفكرة
- منا أن تظهر اتفاقك مع ما قاله المريض انه ليس سليما بنسبة 100% ويضيف كذلك أي شخص
- ويوضح له خطأه في تقسيمه للشفاء والمرض بشكل منفصل ويوضح له فكره المتصل الممتد بين الصحة والمرض وتطبيقا على حالته يبين له كيف أنه بعد مرور بخبرة العلاج قد تحرك على هذا المتصل الى ان وصل الى نقطة قريبة من نهايته الأخرى .

- وقد يستخدم المعالج التقسيم الثنائي الذي يستخدم المريض "مريض في مقابل سليم" لتوضيح التفكير الهادم للذات الذي يتضمن الخطأ المعرفي " الكل أو اللاشيء".
- ثم بعد ذلك يقوم بتدعيم الهدف المبدئي للعلاج وهو فكرة أن المريض قد تعلم طرقا للتعامل مع مشكلاته بشكل أكثر كفاءة وليس أن "يشفيه" أو يعيد بناء شخصيته
- طريقة أخرى للأعداد لإنهاء العلاج
- هي انه بعد بناء علاقة تكاتفية بين المعالج والمريض يتحول المعالج تدريجيا بحيث يضع مزيدا من المسؤولية في العلاج على عاتق المريض عبر الوقت
- وبذلك يصبح المعالج مستشارا أكثر منه معالجا نشطا .
- هذا التحول التدريجي يخدم كسياق لاختبار قدرة المريض على العمل مع المشكلات بنفسه
- من المفيد أيضا في سبيل الاعداد لإنهاء العلاج أن يتم الاتفاق قبل انتهاء العلاج بعده أسابيع أن يتم التباعد بين الجلسات
- فيقوم المعالج بمناقشة فكرة جعل الجلسات مره كل أسبوعين بدلا من جلسة كل أسبوع
- بعض المرضى يتقبل تلك الترتيبات وبعض المرضى تقلقهم بشده هذه الفكرة. وهؤلاء الذين يبدون قلقا قد يكون من المفيد أن يقومون بكتابة قائمة بمميزات خفض معدل الزيارات
- وإذا فشل المريض في رؤية أي مميزات فإن المعالج يوجهه من خلال الاستفسار السقراطي ليساعده في ما قد يكون هناك من مميزات
- أو أن يطلب منه المعالج أن يذكر الافكار الذاتية السلبية المتعلقة بذلك . ثم يقوم المريض بالرد على تلك الافكار
- ويعد ذلك تنمية لمهارة تحدي الافكار التي تعد مهارة مهمة يتوقع من المريض أن يكتسبها بعد انتهاء العلاج .
- أخيرا فإن من المفيد ان المعالج والمريض قد يتفقا على أن يتقابلون فيما يدعي جلسة تنشيطية من أجل متابعة العمل الذي تم إنجازه.

- ولقد ثبت فعالية هذا الاجراء الجلسات التنشيطية ويتم الاتفاق على معدلاتها بين المعالج والمريض في نهاية العلاج وقد تعقد بمعدل جلسة كل 3 شهور أو 6 شهور أو جلسة كلما استدعى الامر 0 وذلك بناء على تقدير المريض والمعالج .
- وهذا يقلل من قلق المريض انه سيتترك بمفرده في مواجهه المشكلات .

Abdulaziz Aljemaiah

Senior Clinical Psychologist

•

Abdulaziz Aljemaiah

Senior Clinical Psychologist